

44 - 03-Diarrhée chronique - Pr. Samlani

Bonjour, ce cours est intitulé la diarrhée chronique. La diarrhée chronique est définie comme étant l'émission de sel trop liquide, trop abondante, trop fréquente pendant 4 semaines ou plus, de manière continue ou intermittente. C'est un symptôme qui est relativement fréquent, qu'on retrouve beaucoup en consultation et en hospitalisation.

Il est multifactoriel, ça veut dire que les causes en sont multiples. Il faut savoir établir le diagnostic de diarrhée chronique et réaliser une enquête diagnostique méthodique. Différentes de diarrhée chronique existent.

Quand il s'agit d'une altération des capacités d'absorption, on parle de diarrhée par malabsorption. Quand il y a une sécrétion hydroélectrolytique dépassant les capacités d'absorption, c'est une diarrhée sécrétoire. Quand il y a des substances osmotiquement actives qui vont entraîner un influx liquidien dans le côlon, c'est une diarrhée osmotique.

Quand il y a une accélération du transit, c'est une diarrhée motrice. Enfin, quand il y a la fuite dans le tube digestif de composés sanguins, c'est une diarrhée exudative. Le diagnostic positif est extrêmement simple.

Le patient va vous rapporter la notion de selle, comme on l'a dit, trop fréquente, trop abondante, qui dure pendant plus de 4 semaines. Le diagnostic différentiel se fait avec les fausses diarrhées des constipations chroniques. Parfois, suite à un fécalome à son évacuation, il peut y avoir des évacuations très importantes.

Autre diagnostic différentiel, c'est l'incontinence anal. Et enfin, il faut penser aussi aux diarrhées aiguës prolongées. Le diagnostic étiologique repose sur une enquête étiologique minutieuse.

Cette enquête débute par un bilan initial. Il va reposer sur un interrogatoire et sur un examen clinique qui doit être complété avec un examen général, un examen abdominal et un examen proctologique. L'interrogatoire va rechercher l'âge du patient et ses antécédents personnels et familiaux, de troubles fonctionnels intestinaux, de maladies auto-immunes, notamment la maladie cœliaque, de néoplasie, de cancer colorectal et de néoplasie endocrinienne multiple, de résection intestinale, de chirurgie abdominale, d'irradiation de l'abdomen, d'endocrinopathie, tel que le diabète et les dystyroïdies, de voyages avant le début de la diarrhée.

Et il faut toujours rechercher les prises médicamenteuses dans les trois mois précédents, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la chimiothérapie et autres médicaments. Ensuite, il faut caractériser la diarrhée, c'est-à-dire voir son ancienneté et le mode évolutif. Est-ce que c'est une diarrhée qui est soudaine ou bien une diarrhée qui s'est installée progressivement.

Et bien sûr, il faut voir ou demander l'aspect des selles, si elles sont volumineuses, si elles sont baveuses, c'est-à-dire comme de la bouse de vache, si elles sont grasses. Et dans ce cas-

là, le patient va vous dire qu'il retrouve une auréole grasseuse sur le papier hygiénique. Il va vous décrire donc ce caractère gras.

Si elles sont liquidiennes, s'il y a du sang, si elles sont hémorragiques ou glaireuses. Et il faut rechercher également la présence d'aliments non digérés dans les selles. Ce sont les résidus des aliments.

Il faut poser des questions précises au patient, lui demander si après avoir mangé par exemple des carottes, il retrouve des débris ou des résidus d'aliments ou de carottes qu'il a mangés dans ses selles. Il faut préciser ensuite l'horaire des selles, si elles sont diurnes ou nocturnes, ou bien diurnes et nocturnes. Et le rôle de l'alimentation.

Est-ce que les selles surviennent après le repas directement dans le quart d'heure ou bien au réveil, ceci en faveur d'une diarrhée motrice ? Si les selles sont réparties dans la journée et indépendamment, ça peut être en faveur d'un caractère organique de ces diarrhées. Il faut rechercher le degré d'impériosité de la selle. Ça veut dire que le patient est obligé de courir pour pouvoir faire sa selle, parce que sinon il est incapable de se retenir.

C'est en faveur d'une diarrhée motrice. Et l'efficacité des ralentisseurs de transit, qui est également en faveur d'une diarrhée motrice. Ensuite, on recherche les signes associés.

L'amaigrissement, l'altération de l'état général, l'anorexie, la fièvre, des signes digestifs, des douleurs, des crampes, des hémorragies digestives extériorisées et les signes extra-digestifs, notamment les arthralgies, l'hypotension, un flush syndrome, c'est une rougeur que le patient va ressentir, va se voir sur ses joues, et bien sûr des signes ophtalmologiques en faveur d'une atteinte ophtalmologique telle qu'une uvéite. L'examen abdominal sera réalisé. Il va rechercher une douleur abdominale, une masse abdominale, une splénomégalie, une hépatomégalie et il sera toujours complété par le toucher rectal.

Le toucher rectal sera précédé d'une inspection de la marge anale qui va voir s'il n'y a pas des fissures, des abcès. Et puis le toucher lui-même va rechercher la présence d'une masse rectale et puis va évaluer le sphincter pour voir s'il n'y a pas une hypotonie sphinctérienne. Et le reste de l'examen clinique sera réalisé en totalité avec la palpation des ganglions, notamment le ganglion de Troisiers et susclaviculaire gauche, la palpation cervicale à la recherche d'un goitre et l'examen neurologique cutané-ostéoarticulaire seront réalisés, de même bien sûr que l'examen pluripluminaire cardiovasculaire.

Au terme de cet examen, il faut évaluer le retentissement. Ceci par l'évaluation du poids du patient, de sa masse musculaire, de son degré de déshydratation, rechercher les signes carenciels chroniques, les anomalies des ongles, des cheveux cassants, des cheveux donc fragiles, des ongles qui sont cassants également, une langue dépapillée, voir si le patient présente des infections à répétition et bien sûr toujours rechercher une anémie qui peut se manifester par des conjonctives décolorées, par une pâleur mais également par une tachycardie et par la

présence d'un souffle inorganique. Vous voyez ici en haut à gauche des altérations des cheveux, c'est une alopécie, des ongles cassants et une langue dépapée, ce sont des signes carenciels.

Vient ensuite l'étape des examens complémentaires. Les examens complémentaires seront scindés en deux types d'examens complémentaires. On a d'abord des examens généraux et d'examens d'orientation qu'on va faire.

C'est un bilan général qu'on va réaliser avec une numération en formule sanguine. Cette numération en formule sanguine va rechercher une anémie carencielle, une protéine séréactive qui recherche un syndrome inflammatoire, un ionogramme avec natrémie, kaliémie, calcémie, phosphorémie, magnésémie et en cas de diarrhée importante, on complète par une fonction rénale. On fera également une ferritinémie et on fera le dosage de la vitamine B12 et des folates sériques et on fera un temps de quick à la recherche d'une éventuelle carence en facteur de coagulation vitamine au cas dépendant 2, 7, 9 et 10 par malabsorption de la vitamine.

D'autres examens s'imposent à la recherche d'étiologie fréquente, c'est la coproparasitologie des selles, c'est la TSH à la recherche d'une hyperthyroïdie qui peut expliquer ces diarrhées, c'est la sérologie HIV et quand on suspect une maladie céliaque, on peut faire aussi les anticantitransglutaminases. Si elles sont positives, c'est en faveur d'une maladie céliaque. Un bilan endoscopique est également utile quand il y a une diarrhée chronique.

La coloscopie permettra en fait d'explorer l'ensemble du cadre colique et permettra bien évidemment de voir s'il n'y a pas une colite, s'il n'y a pas un cancer. La fibroscopie se fera avec biopsie du dénal et l'exploration du grêle pourrait être faite si nécessaire par entéroscopie ou par capsule endoscopique. Une fois ingérée, cette capsule va enregistrer les images de tout ou d'une partie de la muqueuse d'intestin grêle.

Elle ne permet pas de faire des biopsies, mais elle permettra de retrouver des lésions. Ce que vous voyez ici, c'est l'aspect à la fibroscopie du duodenum. Donc à gauche, on a un duodenum qui est d'aspect normal avec des plis du dénal qui sont normaux et à droite, vous avez des plis qui sont effacés et les biopsies vont montrer une certaine correspondance.

À gauche, vous avez un aspect qui est tout à fait normal et à droite, vous avez une atrophie vilositaire. Donc comme vous avez bien vu, les vilosités sont complètement abrasées. D'autres examens seront réalisés en deuxième intention et sont plus spécifiques.

Ce ne sont pas des examens de routine. C'est le cas du fécalogramme qui permet d'étudier les selles émises pendant trois jours. Le poids normalement de ces selles est à faire 200 g par jour.

C'est le cas du dosage des graisses après supplémentation par 100 g de graisse par jour. Si le débit est super 7 g, il est pathologique et on parle de stéatorée. C'est un signe en faveur d'une malabsorption.

C'est le cas du test au rouge karma qui mesure la vitesse du transit oroanal. Et quand il est inférieur à 8 heures, on parle d'accélération et c'est en faveur d'un transit accéléré d'une diarrhée motrice. C'est le cas du trou osmotique qui mesure la teneur fécale en sodium et potassium.

Quand il est supérieur à 50, on suspecte la présence de selles osmotiquement actives. C'est en faveur d'une diarrhée osmotique. C'est le cas du test respiratoire au glucose.

Le glucose est normalement vite complètement absorbé dans la partie supérieure à l'intestin grêle. En cas de pullulation microbienne dans l'intestin grêle, les bactéries qui fermentent le glucose avant son absorption produisent de l'hydrogène qui sera absorbé dans le sang puis trouvé dans l'air expiré. Ce test mesure l'hydrogène dans l'air expiré à intervalles réguliers après ingestion de 50 g de glucose.

Et enfin, la clairance d'alpha 1 antitrypsine. La clairance d'alpha 1 antitrypsine dont le calcul va nécessiter une détermination du taux sérique également de cette molécule, normalement inférieure à 20 mL par 24 heures, des valeurs supérieures vont témoigner d'une excudation importante des protéines dans la lumière digestive. On peut avoir également recours à des imageries.

C'est le cas de l'échographie abdominale mais surtout la tomодensitométrie abdominopelvienne qui peut explorer le pancréas, chercher ou voir un cancer colique et rechercher également une carcinose péritonéale. C'est le cas d'un autre examen qui est l'octreoscan qui détecte la radioactivité de l'octreoti. C'est un analogue de la somatostatine marquée qui va se fixer sur les tumeurs endocrines.

Donc au terme de ce bilan initial fait d'interrogatoires, d'examens cliniques et d'examens complémentaires, on peut scinder les diarrhées en diarrhées sans malabsorption ou diarrhées avec malabsorption. La diarrhée sans malabsorption, c'est une diarrhée où les selles ne sont pas grasses, où il n'y a pas de syndrome carentiel, où il n'y a pas de stéatorée. Et elle reconnaît quatre mécanismes, diarrhées motrices, sécrétoires, osmotiques ou exudatives.

Ces diarrhées par malabsorption peuvent être diétologie multiple, médicamenteuse, organique ou parasitaire. Les causes médicamenteuses, ce sont les prises de certains médicaments. Je vous avais dit qu'à l'interrogatoire, il faut toujours rechercher la prise des médicaments dans les trois mois précédant ce symptôme, notamment les laxatifs.

Alors la prise des laxatifs de manière chronique pour des patients constipés peut provoquer une diarrhée à part altération ou irritation de la muqueuse colique. Ce sont les biguanides, c'est la colchicine. Parfois, la diarrhée chronique est un signe d'alarme de surdosage.

C'est le cas pour certains médicaments comme les digitalics et la kiwi. Deuxième étiologie, ce sont les causes organiques, notamment les cancers, les cancers colorectaux, les colites inflammatoires et les colites radiques secondaires ni radiations. Troisième étiologie, ce sont les

parasitoses.

La recherche des étiologies dont je viens de vous parler, médicamenteuses organiques parasitaires, est en principe simple. On peut la faire par l'interrogatoire, l'examen clinique, par des examens biologiques simples, une coproparasitologie des selles, un bilan inflammatoire, par des examens endoscopiques simples. Mais s'il n'y a pas d'orientation, c'est à ce moment-là qu'on passe aux explorations de deuxième intention.

Le test au rouge karma consiste en l'ingestion d'un colorant, qui est le rouge karma, par le patient. Si diarrhée motrice, la première selle colorée va apparaître rapidement en moins de 8 heures et la dernière selle va disparaître en moins de 24 heures. On peut procéder également à une épreuve du jeûne du patient pendant 48 heures, c'est-à-dire qu'on va isoler le patient dans une chambre et on va couper toute forme d'alimentation.

La diarrhée osmotique par ingestion de l'axatif ou de substances osmotiquement actives va disparaître et répondre à l'épreuve du jeûne. La diarrhée motrice, parce que le patient ne mange pas, va répondre partiellement ou totalement au jeûne, mais une diarrhée sécrétoire ne cèdera pas au jeûne. Il y a également le trou osmotique qui sera réalisé au besoin et quand il est supérieur à 120 mOsm par kg, on parle de diarrhée osmotique.

La diarrhée motrice peut avoir pour étiologie une colopathie fonctionnelle, une cause hormonale, notamment une hyperthyroïdie, des tumeurs carcinoïdes, une cause neurologique, on citera la neuropathie diabétique. La diarrhée osmotique est une diarrhée qui cède au jeûne où le trou osmotique est élevé. Elle peut être secondaire à une prise clandestine de l'axatif osmotique, c'est pour ça que l'épreuve du jeûne est bonne et positive.

Elle peut être secondaire également à une ingestion trop importante de lactose ou à une carence en lactase. La diarrhée sécrétoire est généralement une diarrhée qui est abondante, hydrique, supérieure à 500 mL par jour, elle ne régresse pas au jeûne et il n'y a pas de trou osmotique. Les étiologies sont les colites, les colites inflammatoires ou autres, les tumeurs endocriniennes, sécrétants de la gastrine ou le VIP.

Enfin, dernier type de diarrhée chronique, ce sont les diarrhées exudatives. Celles-ci résultent de la fuite dans la lumière digestive de composants du sang, de protéines, de cholestérol, de lymphocytes. Elles peuvent être secondaires à des lésions ulcérées de la muqueuse digestive ou à une fuite lymphatique intestinale.

Elles sont confirmées par la clairance en alpha-antitrypsine. Les étiologies sont multiples, ça peut être des lésions étendues au cours de la maladie de Crohn ou bien des lymphos. Après avoir vu les diarrhées chroniques sans malabsorption, on verra les diarrhées avec malabsorption.

La diarrhée avec malabsorption peut être scindée en deux types. Il y a la diarrhée avec maldigestion où le problème est un problème de digestion avant même l'absorption. Et la

diarrhée avec malabsorption ou par malabsorption proprement dite.

Généralement ce sont des selles qui sont volumineuses, réparties sur la journée, qui sont grasses avec une auréole huileuse sur le papier hygiénique comme on a dit. Et pour les diarrhées avec maldigestion, l'origine en est une dégradation insuffisante des aliments. Elles peuvent être pancréatiques quand il y a une insuffisance pancréatique exocrine secondaire à une pancréatectomie ou à une pancréatite chronique.

Elles peuvent être biliaires par insuffisance biliaire ou bien gastriques quand il y a une gastrectomie. Le diagnostic étiologique est souvent porté à l'interrogatoire et sur l'imagerie abdominale. La diarrhée par malabsorption proprement dite peut être d'origine pariétale.

Cela veut dire que c'est un problème au niveau de la paroi intestinale qui est en cause. C'est le cas des atrophies vilositaires comme on avait vu pour la maladie Celiac. Les atrophies vilositaires peuvent également être secondaires à des parasitoses comme la giardiose.

C'est le cas de la maladie de Whipple. La maladie de Whipple est une maladie systémique rare qui est provoquée par une bactérie. Et parmi ces symptômes, on peut retrouver une diarrhée chronique.

C'est le cas de la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire chronique intestinale qui peut toucher de la bouche à l'anus. Et c'est le cas également quand il y a eu des réssections intestinales.

Cela veut dire une chirurgie intestinale. D'autres maladies intestinales peuvent provoquer une diarrhée par malabsorption. C'est le cas de la tuberculose et des lymphomes.

Et enfin, c'est le cas des insuffisances artérielles qui peuvent provoquer des ischémies, des défaillances vasculaires et entraîner une malabsorption. En conclusion, la diarrhée chronique est une pathologie multifactorielle. La stratégie d'exploration est décidée au cas par cas, en fonction de l'interrogatoire et des premiers examens biologiques d'orientation.

Il faut savoir hiérarchiser les examens complémentaires. Il y a des situations qui sont fréquentes. Par exemple, une diarrhée motrice ancienne qui a traîné chez un adulte qui est jeune, sans intérêt à l'état général, sans aucune anomalie à l'examen clinique premier et qui répond bien à un traitement symptomatique, peut être secondaire à une colopathie fonctionnelle.

Une diarrhée chronique survenant à un âge qui est plus tardif, avec des rectorragies, avec des signes inquiétants à l'examen abdominal, la présence d'une masse ou la présence d'une ascite, peut faire penser à un cancer du côlon, du pancréas ou une carcinose. Une diarrhée après prise médicamenteuse récente peut faire évoquer un surdosage médicamenteux. Donc les situations vont de situations simples, nécessitant peu d'exploration, à des situations complexes où il faudra aller plus loin dans les explorations biologiques, morphologiques, fonctionnelles et

endoscopiques.